

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient's Copy Cholecystectomy – Open & Exploration of the Common Bile Duct

معلومات الإقرار – نسخة المريض
استئصال المرارة بالفتح الجراحي مع استكشاف قناة
الصفراء (المرّة) المشتركة

1. What is a cholecystectomy - open and exploration of the common bile duct?

Removal of the gall bladder through a cut at least 10 cms (4 inches) long across the right side of the abdomen, just below the rib cage. The surgeon will also examine the tube, which carries bile from the liver to the bowel and remove any stones. . A drainage tube (a T-Tube) will be inserted into the tube and brought out through the abdomen to drain bile into a drainage bag on the outside of the body. The tube will be removed in 3-6 weeks. During surgery an examination of the bile duct is required to look for gallstones. To do this a Contrast medium is injected and x-rays are taken of the bile duct.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning

ما هو استئصال المرارة بالفتح الجراحي مع استكشاف قناة الصفراء (المرّة) المشتركة؟

إزالة المرارة من خلال شق جراحي طوله 10 سنتيمتر (4 بوصات) على الأقل ، يمتد عبر الجانب الأيمن للبطن ، مباشرة أسفل القفص الصدري . يقوم الجراح كذلك بفحص الأنبوب الناقل للمادة الصفراء من الكبد إلى الأمعاء لإزالة أي حصوات . يتم إدخال أنبوب تصريف باللاتيني في الأنبوب المراري وإخراجه إلى (T على شكل الحرف) خارج البطن لسحب وتصريف المادة الصفراء وتجميعها في كيس تصريف خارج الجسم. تتم إزالة هذا الأنبوب بعد 3 – 6 أسابيع حصوات المرارة . يتطلب الأمر فحص القناة المرارية بحثاً عن وللقيام بذلك يتم حقن صبغة متوسطة التركيز مع أخذ صور بالأشعة السينية للقناة المرارية .

2. التخدير الذي أتلقاه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟ لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Damage to nearby blood vessels causing bleeding which could require an emergency blood transfusion and further surgery.
- Gallstones may spill from the gall bladder and be lost in the abdominal cavity. These may form abscesses, which may need drainage.
- Some stones may be left behind in the bile duct and may need further treatment.
- The T-tube may come out of position. Further surgery may be required to re-insert the T-Tube.
- Metal clips may be put on blood vessels or ducts and some of the clips or ties may come off and cause a bile leak or bleeding which may become infected. This may need drainage. The metal clips will always stay in the abdomen.
- Damage to the bile tubes near the liver and gall bladder which can cause short and long-term problems with leakage and/ or blockage.
- Difficulty passing urine after the operation. This may need a tube (catheter) passed into the bladder to remove the urine. This is usually temporary.

- الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبياردامول (بيرسانتين أو اساسانتين) قد يحدث انسداد للشعبيات الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر. مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة متعلقة بهذا الإجراء:

- ضرر يصيب وعاء دموي مجاور مسبباً نزيف، مما قد يتطلب نقل دم طارئ أو جراحة أخرى.
- قد يحدث سقوط للحصوات من المرارة وقد تبقى داخل البطن. قد يؤدي ذلك لتكوّن خراج مما قد يتطلب الإفراغ لمكوناته.
- قد تترك بعض الحصوات في القناة المرارية وقد تكون هناك حاجة لمعالجة أخرى.
- الأنبوب ذو الشكل T قد يخرج من مكانه. قد يتطلب الأمر جراحة أخرى لإعادته إلى موضعه.
- قد توضع المشابك المعدنية على الأوعية الدموية أو القنوات الصفراوية. بعض المشابك أو الأربطة قد تنفصل وتخرج من مكانها وتسبب تسرب للمادة الصفراء أو نزيف والذي قد يتعرض للالتهاب. قد يتطلب ذلك السحب والتصريف.
- المشابك المعدنية تظل داخل البطن للأبد.
- حدوث ضرر للأنابيب المرارية بالقرب من الكبد والحويلة المرارية مسبباً مشكلات قصيرة وطويلة الأمد من التسريب وأو الانسداد.
- صعوبة في إدرار البول بعد الجراحة، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة لإخراج البول. يكون هذا عادة لفترة مؤقتة.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Occasionally after the T-tube is removed, 2 or 3 weeks after the operation, bile may leak out of the bile duct to the skin or into the abdominal cavity.
- Infection in the wound causing redness, pain and possible discharge or abscess. This may need antibiotics.
- Possible bleeding into the wound with swelling and bruising and possible blood stained discharge.
- The wound may not heal normally. The wound can thicken and turn red. The scar may be painful.
- A weakness can happen in the wound with the development of a hernia (rupture). Further surgery may be needed to correct this.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long-term complication and may need further surgery.
- Symptoms experienced before surgery may persist after the surgery.
- An allergic reaction to the injected contrast is rare.

Notes to talk to my doctor about:

- في بعض الأحيان ، وبعد إزالة أنبوب (T) بعد مرور 2-3 أسابيع من الجراحة ، قد تتسرب المادة الصفراء من القناة المرارية إلى الجلد أو التجويف البطني.
- التهاب في الجرح مسببةً احمرار ، ألم ، مع احتمال وجود تسريب لسوائل أو خراج. قد يتطلب ذلك مضادات حيوية.
- قد يحدث نزيف داخل الجرح مع تورّم وكدمة وخروج سوائل لها لون الدم.
- قد لا يلتئم الجرح بشكل طبيعي . قد تزداد سماكته ويصبح لونه أحمر ، وقد يكون الندب مؤلماً.
- ضعف في موقع الجرح مما يؤدي إلى نشوء فتق (تمزق). قد يتطلب إصلاح ذلك جراحة أخرى.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- قد لا تختفي أعراض ما قبل الجراحة بعد الخضوع للجراحة.
- من النادر حدوث رد فعل تحسسي لصبغة الأشعة السينية (الوسط المتباين) التي يتم حقنها.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
